

Rwa kulszowa

1. tydzień - Etap wprowadzający - technika, tolerancja ruchu, mała/umiarkowana objętość.

Cel
Łagodne utrzymanie ruchu, poprawa tolerancji obciążenia i ślizgu struktur nerwowych bez nasilania objawów w nodze.

Uwaga kliniczna
W rwie nie ma jednego dobrego kierunku ruchu dla wszystkich. Wybieraj ćwiczenia, po których ból/drętwienie nie schodzi dalej do stopy. Pilna konsultacja: drętwienie okolicy krocza, zaburzenia oddawania moczu/stolca, szybko narastające osłabienie nogi lub objawy obustronne.

1 JOGA 1

Sfinks - łagodny wyprost

Połoń się na brzuchu, oprzyj przedramiona pod barkami i unieś klatkę bez zaciskania pośladków. Biodra zostają na podłożu. Oddychaj spokojnie. Wykonuj tylko wtedy, gdy objawy w nodze nie nasilają się ani nie schodzą niżej.

Dawka: 20-30 s x 3-5

Wskazówka: Ruch ma być komfortowy; może być odczuwalny w plecach, ale nie powinien zwiększać promieniowania.

2 JOGA 2

Pozycja dziecka z szeroko ustawionymi kolanami

Usiądź pośladkami w kierunku pięt, kolana ustaw szerzej i wyciągnij ręce do przodu. Nie wciskaj się na siłę w zgięcie. Jeśli zgięcie nasila promieniowanie, pominię tę pozycję.

Dawka: 20-40 s x 2-3

Wskazówka: Wybieraj tylko kierunek, po którym noga czuje się tak samo lub lepiej.

3 POZIOM 1 - łatwy

Ślizg nerwu kulszowego w leżeniu

Połoń się na plecach. Zegnij biodro i kolano do wygodnej pozycji, podtrzymując udo rękami. Powoli prostuj kolano i jednocześnie kieruj palce stopy do siebie; wracając, zegnij kolano i rozluźnij stopę. To ma być płynny ślizg, nie mocne rozciąganie.

Dawka: 8-12 powt. x 1-2 serie

Wskazówka: Bez długiego przytrzymania i bez wywoływania narastającego mrowienia.

4 POZIOM 2 - średni

Most biodrowy

Leżenie na plecach, kolana ugięte, stopy na szerokość bioder. Lekko napnij brzuch i unieś miednicę do linii barki-biodrakolana. Opuść powoli. Nie wyginaj mocno odcinka lędźwiowego.

Dawka: 8-12 powt. x 2-3 serie

Wskazówka: Ciężar rozłóż równo na obu stopach.

5 POZIOM 3 - trudniejszy

Bird dog - ręka i przeciwna noga

Kłęk podparty. Utrzymaj spokojny tułów i wyprostuj jednocześnie jedną nogę oraz przeciwną rękę. Wróć bez kołysania miednicą i zmień stronę.

Dawka: 6-10/stronę x 2-3 serie

Wskazówka: Zakres kończyny mniejszy, jeśli pojawia się ból promieniujący.

Zasada progresji: przejdź do kolejnego etapu dopiero, gdy technika pozostaje dobra, a objawy nie są wyraźnie gorsze po sesji ani następnego dnia.
Program dobiera fizjoterapeuta do badania i tolerancji pacjenta.